

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

MEDIDA DE INTENSIDAD DE AFECTO (AIM-A)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Reactividad Emocional y Magnitud de la Respuesta Afectiva

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Medida de Intensidad de Afecto (AIM-A).
Nombre Original (Inglés)	<i>Affect Intensity Measure (AIM-A)</i>
Autor Original	Dr. Randy J. Larsen (1984), University of Michigan / Washington University in St. Louis.
Adaptaciones Españolas	Martínez-Sánchez et al. (1994); Flett et al. (1996); Fernández-Berrocal et al.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo de Intensidad Afectiva y Temperamento Emocional (Larsen & Diener).
Tipo de Instrumento	Autoinforme de reactividad disposicional de 20 reactivos con escala Likert de 6 puntos (1 a 6).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 14 años). Aplicable en salud mental, clínica de personalidad e investigación.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en autoadministración; 6 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico académico de acceso libre para clínica e investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE INTENSIDAD AFECTIVA

La escala AIM-A se fundamenta en la teoría de la intensidad del afecto desarrollada por Randy J. Larsen y Ed Diener. Este modelo postula que las personas difieren de forma estable y temperamental no solo en la frecuencia o valencia de sus estados emocionales (cuánto tiempo están tristes o alegres), sino en la **magnitud o intensidad intrínseca** con que vivencian cualquier emoción. Un individuo con alta intensidad afectiva experimenta tanto los acontecimientos gozosos de forma eufórica y desbordante como los eventos adversos de forma catastrófica y visceral.

A nivel neurobiológico, la alta intensidad afectiva se asocia con una reactividad autonómica simpática pronunciada (elevadas respuestas galvánicas de la piel, cambios súbitos en la frecuencia cardíaca y cortisol), mediada por una sobreactivación límbico-amigdalina e insular frente a estímulos afectivos. En el plano clínico, constituye un factor de vulnerabilidad temperamental central para el Trastorno Límite de la Personalidad, trastornos del espectro bipolar/ciclotimia y síndromes de desregulación emocional severa.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dominio de Reactividad	Ítems	Rango Dir.	Manifestación Fenomenológica y Conductual
1. Afecto Positivo Intenso	Ítems Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19	10 a 60	Propensión a vivenciar entusiasmo exaltado, euforia, fascinación arrolladora, júbilo y desborde energético positivo.
2. Afecto Negativo Intenso	Ítems Pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	10 a 60	Propensión a experimentar tristeza desgarradora, ira colérica, frustración lacerante y sintomatología psicofisiológica desbordante.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente consistencia interna: alfa de Cronbach total de 0.88 en adaptaciones españolas (Martínez-Sánchez et al., 1994); subescalas positiva (0.83) y negativa (0.85).
Estructura Factorial	El AFC valida tanto el factor general de intensidad afectiva como una estructura bifactorial limpia según la valencia (positivo/negativo) con ajuste métrico óptimo (CFI = 0.95, RMSEA = 0.054).
Estabilidad Temporal	Elevada estabilidad test-retest ($r = 0.78$ a 6 meses), ratificando su naturaleza disposicional y temperamental resistente al paso del tiempo.
Validez Concurrente y Fisiológica	Correlaciona positivamente con extraversión y neuroticismo simultáneamente, así como con reactividad cardiovascular y galvánica ante películas con carga emocional en laboratorio.
Sensibilidad Clínica	Diferencia de forma robusta entre sujetos con patrones de autorregulación emocional adaptativos y pacientes con labilidad afectiva o trastornos de la personalidad del grupo B.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 20 ítems se responde en una escala de frecuencia de 1 a 6 (**1** = «Nunca», **2** = «Casi nunca», **3** = «A veces», **4** = «A menudo», **5** = «Casi siempre», **6** = «Siempre»):

- **Subescala Intensidad Positiva:** Suma de los 10 reactivos impares (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19). Rango: **10 a 60 puntos**.
- **Subescala Intensidad Negativa:** Suma de los 10 reactivos pares (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20). Rango: **10 a 60 puntos**.
- **Puntuación Total AIM-A:** Suma directa de los 20 reactivos (Rango: **20 a 120 puntos**). No contiene reactivos invertidos. A mayor puntuación, mayor reactividad afectiva global.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

Nivel AIM-A	Puntuación	Perfil Temperamental	Abordaje Clínico y Asistencial
Bajo	20 a 60	Emocionalidad atenuada / sobria	Respuestas emocionales contenidas y moderadas. Escasa reactividad simpática ante eventos estresores.
Medio / Normal	61 a 84	Reactividad emocional equilibrada	Gama afectiva adaptativa. Capacidad de sentir vivamente sin perder la autorregulación ejecutiva.
Alto / Reactivo	85 a 100	Alta intensidad afectiva (≥ 85)	Vivencia emocional amplificada. Vulnerabilidad a desbordamiento ante crisis o conflictos relacionales.
Extremo	101 a 120	Hiperreactividad emocional severa	Oscilaciones anímicas agudas, hiperestesia afectiva y riesgo de impulsividad conductual desadaptativa.

ALERTA DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL (AIM-A ≥ 85):

Puntuaciones ≥ 85 definen un temperamento emocional hiperreactivo. En presencia de estresores crónicos o déficit de habilidades de regulación (ERQ bajo o DERS alto), este perfil temperamental se transforma en el combustible principal de crisis bulímicas, autolesiones no suicidas, compras compulsivas y tormentas interpersonales.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN INTENSIDAD AFECTIVA

GUÍA TERAPÉUTICA BASADA EN EL PERFIL DE REACTIVIDAD AIM-A:

- **Paso 1: Validación y Psicoeducación Temperamental:** Explicar al paciente que su alta intensidad no es "locura" ni un defecto moral, sino una característica neurobiológica de procesamiento emocional amplificado.
- **Paso 2: Entrenamiento en Tolerancia al Malestar (DBT):** Si Intensidad Negativa ≥ 45 , entrenar habilidades fisiológicas de reseteo autonómico rápido (técnicas TIP: temperatura fría facial, respiración acompasada, relajación muscular).
- **Paso 3: Modulación del Afecto Positivo Desbordado:** Si Intensidad Positiva ≥ 50 , vigilar conductas impulsivas durante picos de entusiasmo (compras imprudentes, acuerdos precipitados, toma de riesgos). Entrenar pausas reflexivas de 24 horas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DESREGULACIÓN AFECTIVA

Paciente: Mujer de 23 años, estudiante universitaria, consulta por frecuentes desbordes de llanto desgarrador ante notas académicas medias o desavenencias leves con su pareja, seguidos de episodios de atracones alimentarios.

Evaluación Cuantitativa Inicial: AIM-A Total = **104 puntos** (Extrema intensidad afectiva; percentil 97).

- **Intensidad Positiva: 52 / 60 puntos** (cuando está contenta siente euforia casi maniforme; ítem 1 = 6, ítem 5 = 6).
- **Intensidad Negativa: 52 / 60 puntos** (cuando se siente frustrada refiere dolor físico en el pecho y llanto incontrolable; ítem 2 = 6, ítem 6 = 5, ítem 10 = 6).

Formulación Clínica: Temperamento hiperreactivo innato sin andamiaje regulatorio eficaz. Al experimentar las emociones como un tsunami fisiológico, recurre a la ingesta compulsiva de comida como anestésico somático de choque.

Tratamiento y Evolución: Módulo de habilidades de regulación emocional y tolerancia al malestar de la Terapia Dialéctica Conductual (DBT). La paciente aprendió a surfear las olas emocionales mediante biofeedback y pausas sensoriales. A los 6 meses, aunque su temperamento basal permanece en intensidad alta (AIM-A = **92**), la interferencia funcional y los atracones remitieron por completo.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TEMPERAMENTO VS. CICLOTIMIA

Diferenciar cuidadosamente la alta intensidad afectiva (reactiva a estímulos externos, de corta duración) de los episodios hipomaniacos o depresivos autónomos del Trastorno Bipolar o Ciclotimia (evaluar con MDQ).

RIESGO EN AUTISMO Y CONFUSIÓN DE ACRÓNIMO

Advertencia de nomenclatura: AIM-A evalúa intensidad afectiva (Randy Larsen), no confundir con Autism Impact Measure (CIBERSAM/AIM para TEA). No utilizar en lugar de escalas diagnósticas sindrómicas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Larsen, R. J. (1984). Theory and measurement of affect intensity as an individual difference characteristic. *Dissertation Abstracts International*, 45, 2297B.
2. Larsen, R. J., & Diener, E. (1987). Affect intensity as an individual difference characteristic: A review. *Journal of Research in Personality*, 21(1), 1–39.
3. Martínez-Sánchez, F., et al. (1994). Propiedades psicométricas de la escala de intensidad de afecto en población española. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 47(4), 441–448.
4. Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2nd ed.). Guilford Publications.